

Erihoolekande teenus-süsteemi arendamine teenuse disaini toel



Katrin Tsuiman

nõunik, sotsiaalministeerium

2016. a alustati sotsiaalministeeriumi juhtimisel ja Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toel erihoolekandeteenustele uue teenusesüsteemi aluste loomist, kasutades teenuse disaini metoodikat ja tööriistu.

Tegevus on seotud erihoolekande arengukavaga 2014–2020, mille üks eesmärke on toetada erihoolekandeteenuste osutamist kogukonnas, ning heaolu arengukavaga 2016–2020, mis näeb ette paindlike ja uuenduslike lahenduste arendamist, mis aitaksid ressursisäästlikult inimeste vajadustele vastata.

Disainiprotsessi tulemusena nähakse ühe võimaliku arenguna kohaliku omavalitsuse suuremat rolli erihoolekandeteenuste pakumisel. On peetud otstarbekas, et kohalik omavalitsus vastutab teenuste korraldamise eest, kuna asub inimesele kõige lähemal ning omab ülevaadet ja võimalusi kogukonna ressursside kaasamiseks – see kindlustaks teenuste isikukesksuse. Uut mudelit katsetatakse omavalitsustes ning tulemuste põhjal hinnatakse, kuidas süsteem võiks edaspidi toimida.

Mis on teenuse disain?

Teenuse disain on inimesekeskseid ja uusi

lahendusi otsiv tegevus, mis kasutab tootedisaini metoodikat ning loovat mõtlemist. Selle käigus analüüsitakse teenuste funktsionaalsust ja nende osutamise protsessi. Püüeldakse selle poole, et abi ja teenused vastaksid inimese vajadustele, oleksid kasutajasõbralikud ja väärtuslikud nii teenuse pakkujale kui ka kasutajale, ning et teenuste pakkumine oleks efektiivne ja ressursisäästlik. Sotsiaalministeeriumi seatud kriteeriumid näevad ette, et arendusprotsessi tulemusena disainitud teenussüsteem ja uued lahendused:

- ♦ vastaksid sihtgrupi ja tema lähedaste vajadustele
- ♦ säilitaksid ja arendaksid teenuste kasutajate toimetulekuoskusi, võimaldades neil elada võimalikult iseseisvalt ja kogukonda kaasatuna
- ♦ oleksid isikukesksed ja nende osutamise protsess oleks kasutajasõbralik, paindlik ja võimalikult efektiivne
- ♦ lähtuksid teenusele õigustatud inimeste kindlaks määratud vajadustest

- võimaldaksid toimetulekut toetavaid tegevusi ja teenuse sisukomponente paindlikult kombineerida ning kohandada vastavalt sellele, kuidas muutub inimese võimekus ja abivajadus
- oleksid optimaalse ressursikasutusega ning lähtuksid võimalikult palju olemasoleva süsteemi, sidusvaldkondade ja kogukonna võimalustest.

Teenuse disaini etapid

Hanke võitnud partner Trinidad Consulting OÜ koostas aja- ja tegevuskava, mille kohaselt jaotus erihoolekandeteenuste disaini protsess neljaks etapiks. Teenuse disainiga alustati juunis 2016 ning see on kavas lõpule viia selle aasta septembris. Järgnevalt igast etapist lähemalt.

Informatsiooni kogumine. Selles etapis selgitati välja ja täpsustati teenuste sihtgrupi ootused ja vajadused, analüüsiti olemasolevat süsteemi ja teenuste osutamise/kasutamise konteksti ning tutvuti valdkonna toimimist reguleerivate alusdokumentide, varasemate uuringute ja rahvusvahelise praktikaga. Selleks viidi läbi 7 grupiintervjuud, kus osales 46 inimest, kes olid teenusekasutajate, teenuseosutajate, teenuste korraldajate ja rahastajate, tööandjate, avalike teenuste (postkontor, raamatukogu, apteek, kultuuri ja vabaaja asutused) ja tervishoiuteenuse esindajad. Lisaks toimus 38 süvaintervjuud ja vaatlusuuringut, et õppida tundma teenuse kasutajaid ja nendega seotud osalisi. Viidi läbi paikvaatlused 12 erihoolekandeteenuseid osutavas asutuses/üksuses.

Sihtgrupi vajaduste väljaselgitamisel kasutati raamistikuna Maailma Terviseorganisatsiooni vaimse tervise valdkonna elukvaliteedi domeene (psühholoogiline heaolu, füüsiline tervis, iseseisvus, sotsiaalsed suhted, keskkond,

vaimsus ja uskumused)¹ ja erihoolekandeteenuste süsteemi nelja klienditeekonna etappi: kliendi vajaduste märkamine, teenusele saamine, teenuse kasutamine, teenuselt lahku mine või teenuse vahetamine.

Vajaduste ning praeguse süsteemi võrdlemiseks koostati klienditeekonna etappide kaupa tabel. Samuti toodi välja probleemid olemasolevate teenuste kasutamisega ja ootused teenussüsteemiga seotud sidusvaldkondadele.

Lahenduste leidmine. Teises etapis viidi läbi koosloome töötoad, et leida esmaseid uusi lahendusi ja ideid teenuste osutamiseks ja korralduseks. Ühtlasi kirjeldati teenuse kasutajate jaoks kasutajasõbralikke teenustele jõudmise ja teenuste kasutamise teekondi. Tuleviku klienditeekondi püüti kirjeldada nii, et oleksid kaetud võimalikult paljud projekti esimeses etapis selgunud kliendi vajadused.

Koosloome töötoad keskendusid eri toetusvajaduse ja eri psüühilise erivajaduse spetsiifika sihtrühmale: suure toetusvajadusega (8–24 tundi ööpäevas) intellektihäirega ja psüühikahäirega inimesed ja kohtumäärusega teenusele saadetud inimesed ning väikse toetusvajadusega (kuni 8 tundi ööpäevas) intellektihäire ja psüühikahäirega inimesed. Sihtgrupi diferentseerimisel ja lahenduste leidmisel lähtuti inimeste toetusvajadusest ja eripärast, mitte konkreetsest diagnoosist või puude raskusastmest; eraldi käsitleti psüühikahäire ning intellektihäirega inimeste vajadusi. Kokku tegeleti 15 kliendi juhtumi ehk persoonaga. Töötubades osalesid teenuste kasutamise kogemusega inimesed, nende esindajad ja lähedased, teenuseosutajad ja -korraldajad ning valdkonna eksperdid.

Tööprotsesside ja muudatuste disainimine ning kirjeldamine. Varasemate etappide töötulemuste põhjal pandi paika teenuskomponendid, kirjeldati ja visualiseeriti

¹ The world health organization quality of life instruments (THE WHOQOL-100 AND THE WHOQOL-BREF) 1997, www.who.int/mental_health/media/en/76.pdf.

protsessid. Klienditeekonnad digitaliseeriti. Disainerid koostasid uue teenusmodeli prototüübi ja selle variatsioonid ning teenusprotsesside kirjeldused. Lisaks koostati teenuskomponentide tabel ja teenuskomponentide kirjeldused, mida täiendasid ka valdkonna eksperdid.

Disaini protsessi käigus loodud teenusmodel koosneb neljast moodulist: esmane toetus, hädaabi toetus, baastoetus ning lisatoetus. Iga moodul koosneb teenuskomponentidest, millega on võimalik tagada inimesele ja tema lähedastele vajalikud valdkonnas toetus ning millest saab kombineerida inimesele sobiva teenuspaketi. Paketti saab paindlikult kohandada, kui inimese vajadused muutuvad. Kogu abi- ja toetusmeetme jooksul pakub inimesele ja vajadusel tema lähedastele järjepidevat personaalset tuge üks kindel inimene (tugiisik või tegevusjuhendaja).

- ♦ **Esmase toetusega** pakutakse inimesele ja tema lähedastele kiiret ennetavat abi teenussüsteemi sisenemisel (vajadused seal, kus inimene viibib) ning informeeritakse toetusvõimalustest ja õigustest. Ühtlasi viiakse läbi esmane toetusvajaduse hindamine, millele tuginedes saab valida järgmise mooduli raames baastoetuse või hädaabi toetuses sobiva abimeetme pakkuja.

- ♦ **Hädaabi toetust** pakutakse inimesele ja tema lähedastele juhul, kui on vaja kohest abi olukorra stabiliseerimiseks. Kui inimene abist keeldub, siis pakutakse tema pereliikmetele toetust ja vajadusel nõustamist.

- ♦ **Baastoetuse** käigus pakutakse inimesele personaalset tuge kogu teenusega seotuse ajal, põhjalikuma hindamise alusel koostatakse isiklik tegevusplaan. Tegevusplaanis olevate teenuskomponentide omavahelist toimimist koordineerib tugiisik/tegevusjuhendaja.

- ♦ **Lisatoetuse** teenuskomponentidest kujundatakse personaalne teenuspakett, mis arvestab inimese muutuvate vajadus-

tega. Teenuskomponente pakub üks või mitu teenuseosutajat. See peab katma kõiki eluvaldkondi kombineerides erihoolekande, rehabilitatsiooniteenuste ja kogukonna ressursse. Teenuskomponentide grupid on igapäevaeluga toimetulek, eluase, hõivatus, vaimne heaolu, füüsiline tervis, pere toetamine, sotsiaalsed suhted.

Katsetamine ja tulemuste analüüs. Teenusmodelit katsetatakse Sotsiaalkindlustusameti juhtimisel 12 kuu jooksul väikese grupi teenusele õigustatud inimestega. Teenusmodeli katsetamisel on teenuskomponentide põhjal erihoolekandeteenuste korraldamine ja tagamine kohalike omavalitsuste vastutus. Selleks tuleb neil teha palju koostööd tänaste erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste ning kogukondlike toetusmeetmete pakkujatega. Disainerid toetavad katsetamist neli kuud ning koguvad tagasisidet teenussüsteemi sisenemise ja komponendipõhise teenusmodeli kasutamise kohta. Selle põhjal analüüsitakse korraldajate, kasutajate ja nende lähedaste kogemust uutel põhimõtetel rakendava abimeetmete korralduse kohta. Saadud andmetele tuginedes parandavad ja täiendavad disainerid teenusmodelit ja teenuse osutamise protsesse ning koostavad lõppraporti.

Kokkuvõtteks

Erihoolekandeteenuste disaini tulemusena on 2017. a jooksul valmimas ministeeriumi, teenuste kasutajate, nende esindajate ja teenuste osutajatega koostöös loodud teenusmodel ja arendusettepanekud teenussüsteemi ümberkujundamiseks. Tööprotsessis välja toodud komponentidepõhine lähenemine võimaldab jaotada olemasolevad erihoolekandeteenused komponentideks ning nendest lähtudes vaadata üle praeguste teenusekasutajate toetusvajaduse ja kavandada teenussüsteemi muutmiseks vajalikud tegevusprotsessid ja üleminekukava.



Isikukeskse erihoolekande teenusmodeli katsetamine kohalikes omavalitsustes

Sotsiaalkindlustusamet korraldas hanke, et leida kaheksa uuendusmeelset kohalikku omavalitsust, kellele pakub huvi aasta aega katsetada uut erihoolekande teenussüsteemi. Nendeks omavalitsusteks on Haapsalu, Võhma, Keila ja Tallinna linn, Jõhvi, Märjamaa, Otepää ja Vändra vald.

Katsetamine algab 2017. aasta mais. Uue formaadiga teenuseid saavad omavalitsused pakkuda 40 kliendile, kusjuures neil on võimalik ise planeerida teenuste korraldust. Projektis „Isikukeskse teenusmodeli piloteerimine kohaliku omavalitsuse korralduse baasil”² puudub omavalitsustele omaosaluse nõue, sest katsetatavas uues teenusmodelis olevat juhtumitööd psüühikahäirega inimestega tehakse kohaliku omavalitsuse olemasoleva hoolekandeteenuste süsteemi osana.

Projekti sihtgrupiks on raske, sügava või püsiva psüühilise erivajadusega inimesed, kes on tööealised ja seda alates 16. eluaastast, neil ei ole määratud põhidiagnoosina dementsust (eris sotsiaalhoolekande seaduse määratlusega) ega alkoholisõltuvust. Lisaks sellele vajavad nad toimetulekuraskuste tõttu toetust igapäeva- ja ühiskonnaelus osalemiseks teistega võrdsetel alustel ning võimetekohaseks osalemiseks tööhõives, nt kaitstud töö, tööalane rehabilitatsioon, avatud tööturg. Projekt sobib inimesele, kes on erihoolekandeteenusel, mis ei vasta tema abivajadusele; või kes on alles erihoolekandeteenuse järjekorras; või vajab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ning ühiskonnas ja tööturul osalemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Katsetamine on olemuselt muutuv protsess, mis eeldab poolte tihedat suhtlust, et tuua välja nii takistusi kui ka võimalusi isikukesksete teenuste korralduses. Tagasiside on disaineritele väga oluline. Sotsiaalkindlustusamet pakub projektis osalejatele igakülgset abi, et koostöö projekti osaliste vahel oleks võimalikult sujuv.

Pilootprojektile oleme seadnud viis eesmärgi:

- 1) selgitada välja isikukeskse ja komponentidepõhise teenusmodeli sobivus tööealiste psüühikahäirega inimeste toimetuleku ja ühiskonnas osalemise toetamisel
- 2) kaardistada takistusi teenusmodeli rakendamisel ning teenusmodeli toimivust inimeste toimetuleku ja ühiskonnas osalemise toetamisel; täiendada selle põhjal mudelit
- 3) saada ülevaade sihtgrupi hinnatud abivajaduse põhjal koostatud komponentidepõhise teenuste paketi osutamisega seotud kuludest
- 4) saada ülevaade olemasolevate ressursside piires inimesele osutatavast meetmest ja komponentidest koosnevast isiklikust eelarvest ning selleks kasutatavatest ressurssidest
- 5) katsetada teenuse disaini protsessi käigus koostatud sihtgrupi esmase toetusvajaduse hindamise instrumendi sobivust sihtgrupi toetusvajaduse määra väljaselgitamiseks ja edasiste toetusvajaduste katmisega seotud otsuste tegemiseks.

Katsetamiselt saadud andmete ja tagasiside analüüs võimaldab teha kalkuleeritud ja põhistatud otsuseid erihoolekandeteenuste süsteemi muutmiseks, et viia edasi ideid ja põhimõtteid, mis tulenevad nii riiklikest kui ka rahvusvahelistest suundadest.

Raiko Puustusmaa
projektijuht, Sotsiaalkindlustusamet

² Projekt viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteedi „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturul väljalangemise ennetamine” alategevuse „Töövõimereformi sihtühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine” tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine” raames.